



Manual de Documentação e Consentimentos

Documento educacional baseado em referências reconhecidas de segurança do paciente. Não representa protocolo de uma instituição específica.

Finalidade

Orientar registros e conferência documental de maneira compatível com princípios éticos e de segurança. Não substitui normas internas, legislação aplicável ou avaliação profissional.

1. Prontuário

O prontuário reúne informações sobre a saúde do paciente e a assistência prestada, possui caráter legal, sigiloso e científico e favorece comunicação e continuidade do cuidado.

Registros devem ser claros, pertinentes, identificáveis quanto ao profissional e realizados de acordo com as regras do conselho profissional e do serviço.

Não se deve apagar, ocultar ou criar informação que não corresponda ao que ocorreu na assistência.

2. Consentimento livre e esclarecido

O consentimento deve decorrer de informação adequada e compreensível sobre o procedimento, seus objetivos, benefícios esperados, riscos relevantes, alternativas e consequências da não realização, quando aplicável.

O paciente deve ter oportunidade de esclarecer dúvidas e decidir sem coerção, respeitadas as situações previstas em lei.

Quando houver termo escrito, deve ser preenchido de modo legível, identificado e arquivado conforme a rotina institucional.

3. Termo pendente

Quando um termo exigido para o procedimento estiver ausente ou incompleto, a pendência deve ser comunicada à equipe responsável antes do procedimento.

O profissional não deve assinar pelo paciente, preencher declaração como se tivesse sido feita por outro profissional ou registrar consentimento inexistente.

A resolução da pendência e as comunicações relevantes devem ser documentadas no prontuário ou sistema institucional.

4. Recusa do paciente

O paciente capaz pode recusar consentimento, observadas as exceções legais e situações de urgência/emergência.

A recusa deve ser comunicada ao profissional responsável para esclarecimento de riscos, benefícios e alternativas.

Registrar de forma objetiva a recusa, os esclarecimentos realizados e a conduta adotada conforme protocolo institucional.

5. Sigilo e acesso

Informações de saúde são sigilosas. O acesso e compartilhamento devem observar necessidade assistencial, consentimento, dever legal, justa causa e demais hipóteses aplicáveis.

Documentos clínicos não devem ser enviados por canais pessoais ou não autorizados quando isso contrariar as regras de proteção e segurança da informação do serviço.

Referências-base

- Ministério da Saúde / ANVISA / Fiocruz - Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de quedas e segurança no uso de medicamentos.
- RDC ANVISA nº 36/2013 - ações para segurança do paciente em serviços de saúde.
- Conselho Federal de Medicina - Resolução CFM nº 1.638/2002 (prontuário médico) e Recomendação CFM nº 1/2016 (consentimento livre e esclarecido).
- American Society of Anesthesiologists - Practice Guidelines for Preoperative Fasting (referência internacional para jejum em procedimentos eletivos; aplicação depende da avaliação anestésica e do protocolo institucional).

Nota de uso: material preparado para projeto acadêmico de RAG. Na assistência real, prevalecem legislação vigente, protocolos institucionais e avaliação dos profissionais responsáveis.